

CAPÍTULO 12.4

Compromiso de Conciencia, Apraxias, Agnosias y Afasias

PERFIL EUNACOM 1.10.1.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cefaleas Crónicas

NOTA CLÍNICA

Las cefaleas crónicas son **diagnóstico clínico**. No requieren TAC a menos que haya signos de alarma (cambio en la clínica habitual, signo focal, fiebre, etc.).

Migraña (Jaqueca / Cefalea Vascular)

- **Localización:** frontoparietal / retroocular
- **Carácter:** pulsátil u opresivo
- **Síntomas asociados:** fonofobia, fotofobia, náuseas
- **Aura (opcional):** síntoma previo a la crisis (más frecuente: escotoma centellante)
 - - Puede aparecer antes, durante o después de la crisis
 - - Permite "abortar" la crisis si se actúa a tiempo

Tratamiento

TABLA 12.4.1: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Crisis leve-moderada	Paracetamol / AINEs
Crisis intensa	Triptanes (sumatriptán) → 5-HT1 agonista; ergotamina (2ª línea)
Estatus migrañoso	AINEs EV (ketorolaco) + triptanes + antieméticos (metoclopramida) + corticoides (dexametasona)
Profilaxis (≥ 2 crisis/mes)	Propranolol / ácido valproico / amitriptilina / flunarizina

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ergotamina: máximo 2x/semana → riesgo de **cefalea de rebote** (por abuso). Si el paciente la usa diario → diagnóstico es cefalea por abuso de ergotamínicos → suspender + AINEs de soporte.

Cefalea Tensional

- **Localización:** occipital u occipitotemporal ("en cintillo")
- **Carácter:** opresivo ("me duele el cerebro")
- **Sin** fonofobia, fotofobia, náuseas significativas
- Se irradia a musculatura cervical (puede reproducirse con palpación)
- **Causa más frecuente de cefalea** en general

Tratamiento

TABLA 12.4.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS	
	TRATAMIENTO
Crisis	Paracetamol / AINEs
Profilaxis (≥ 2 crisis/semana)	Ácido valproico / amitriptilina (dosis baja nocturna) / flunarizina

Cefalea en Racimos (Cluster / Síndrome de Horton)

- **Carácter:** lancinante, muy intenso (10/10)
- **Localización:** periocular, siempre **unilateral**
- **Síntomas autonómicos ipsilaterales:** miosis, ptosis, ojo rojo conjuntival, rinorrea, epífora
- Desencadenada por alcohol
- Viene en "racimos": crisis múltiples por días/semanas → período libre → nueva etapa

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cluster vs. Glaucoma agudo: - Cluster: ojo rojo **conjuntival (superficial)** + **miosis** - Glaucoma agudo: ojo rojo **periquerático (profundo)** + **midriasis fija**

Tratamiento

TABLA 12.4.3: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Crisis	O: 100% + triptanes SC (no oral)
Profilaxis (durante la etapa de racimos)	Corticoides (máx 3 semanas) → luego verapamilo si se prolonga
Evitar	Alcohol

Neuralgia del Trigémino

- **Carácter:** en ramalazo, eléctrico, muy intenso
- **Localización:** una o más ramas del V par:
 - - Rama oftálmica (V1): frente y ojo
 - - Rama maxilar (V2): mejilla, dientes superiores
 - - Rama mandibular (V3): mandíbula, dientes inferiores
- Puede ser desencadenada al tocar la cara (masticar, afeitarse)

TABLA 12.4.4: TIPO VS EXAMEN NEUROLÓGICO			
TIPO	EXAMEN NEUROLÓGICO	CAUSA	TRATAMIENTO
Primaria	Normal	Idiopática	Carbamazepina (elección) / gabapentina / pregabalina
Secundaria (sintomática)	Alterado (hipostesia, reflejo corneal ↓, disfagia)	Tumor	RNM + tratar causa

Otras Neuralgias

TABLA 12.4.5: NEURALGIA VS LOCALIZACIÓN DEL DOLOR	
NEURALGIA	LOCALIZACIÓN DEL DOLOR
De Arnolt (occipital mayor)	Zona retroauricular / occipital

| Del glosofaríngeo | Garganta / base de lengua, al deglutir |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 55 años llega a urgencias con compromiso de conciencia. Al evaluar la escala de Glasgow obtiene 6 puntos. ¿Cuál es la primera medida a realizar?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Compromiso de Conciencia, Apraxias, Agnosias y Afasias. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Compromiso de conciencia es URGENCIA. Enfrentamiento: ABC + buscar y tratar la causa.
- Primer examen: hemoglucotest (rápido, mucha información). Luego neuroimagen y exámenes generales.
- Glasgow <8 = intubación obligatoria (protección de vía aérea). Mínimo 3, máximo 15.
- Clasificación cuantitativa: sopor superficial (responde al habla), sopor profundo (responde al dolor), coma (no responde a nada).
- Apraxia = quiere hacer pero no puede (motor). Agnosia = percibe pero no reconoce (sensorial). Ambas son síntomas de lesión del SNC.
- Afasia motora (Broca): no habla/escrbe, sí entiende/lee. Afasia sensitiva (Wernicke): no entiende/lee, sí habla/escrbe.
- Afasia de conducción: puede REPETIR. Es por lesión de fibras que unen corteza de Broca con Wernicke.
- Disartria (habla como borracho), dislexia (trastorno aprendizaje lectura), dislalia (pronuncia mal), disfemia (tartamudez): no confundir con afasias.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPROMISO DE CONCIENCIA, APRAXIAS, AGNOSIAS Y AFASIAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 55 años llega a urgencias con compromiso de conciencia. Al evaluar la escala de Glasgow obtiene 6 puntos. ¿Cuál es la primera medida a realizar?

- A)** Solicitar TAC de cerebro urgente
- B)** Intubación orotraqueal
- C)** Administrar naloxona endovenosa
- D)** Solicitar hemograma y perfil bioquímico
- E)** Administrar suero glucosado al 30%

PREGUNTA 2

Paciente de 70 años post-AVE presenta la siguiente alteración: entiende todo lo que se le dice, puede leer sin problemas, pero no logra hablar ni escribir. ¿Cuál es el tipo de afasia?

- A)** Afasia sensitiva o de Wernicke
- B)** Afasia motora o de Broca
- C)** Afasia de conducción
- D)** Afasia mixta
- E)** Disartria

PREGUNTA 3

Paciente llega a urgencias con compromiso de conciencia. ¿Cuál es el primer examen que debe realizarse?

- A)** TAC de cerebro sin contraste
- B)** Hemograma completo
- C)** Hemoglucotest
- D)** Punción lumbar
- E)** Electroencefalograma

RESUMEN: COMPROMISO DE CONCIENCIA, APRAXIAS, AGNOSIAS Y AFASIAS

Esta clase aborda el compromiso de conciencia, las apraxias, agnosias y los trastornos del lenguaje. El compromiso de conciencia es una urgencia por definición, ya que la mayoría de sus causas son graves. El enfrentamiento es con ABC (vía aérea, ventilación, circulación), buscar y tratar la causa. El primer examen es el hemoglucotest, seguido de neuroimagen y exámenes generales. Si el Glasgow es menor a 8, hay que intubar para proteger la vía aérea. El compromiso de conciencia se clasifica en cualitativo (desorientación, pérdida de atención) y cuantitativo: sopor superficial (responde al habla), sopor profundo (responde al dolor) y coma (no responde a ningún estímulo). La escala de Glasgow evalúa respuesta ocular (4 pts), verbal (5 pts) y motora (6 pts), con máximo 15, mínimo 3, e intubación obligatoria bajo 8. Las apraxias son la incapacidad de realizar acciones que antes se podían hacer (quiere pero no puede). Las agnosias son la incapacidad de reconocer o procesar lo que se percibe (percibe pero no reconoce). Ambas son síntomas de lesión del sistema nervioso central. Respecto a las afasias: la motora (de Broca/de expresión) impide hablar y escribir pero permite leer y entender; la sensitiva (de Wernicke/de comprensión) impide entender y leer pero permite hablar y escribir; la de conducción permite repetir; la mixta combina ambas. Se distinguen también la disartria (articula mal, habla como borracho), dislexia (trastorno del aprendizaje para leer), disgrafia (para escribir), dislalia (pronuncia mal) y disfemia (tartamudez).